内江市长期护理保险实施细则

第一章　总　则

第一条　为推动解决失能人员长期护理基本保障需求，根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省建立长期护理保险制度实施方案〉的通知》（川办发〔2026〕6号）文件要求，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条　本细则所称长期护理保险（以下简称“长护险”）是指为失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险。

第三条　我市长护险实行市级统筹，基金统一建账、资金统筹使用。长护险筹资、支付等政策，按照国家、省统一部署，由市医保局商市财政局等部门按程序调整。

第二章　参保筹资

第四条　用人单位以及单位职工、退休人员、灵活就业人员、未就业城乡居民等按照属地管理原则参加长护险。

第五条　长护险与基本医疗保险（以下简称“基本医保”）同步参保、同步缴费。长护险筹资主要由单位缴费、个人缴费、政府补助等构成。积极引入社会力量参与筹资，探索通过慈善捐助、社会捐赠等方式拓展筹资渠道。

第六条　长护险实行费率制征收，执行全省统一的基准费率

和缴费基数。

（一）就业人员

1.单位职工。缴费费率为0.3%，由用人单位和个人按同比例分担，缴费基数与其基本医保缴费基数保持一致。单位缴费应当由用人单位自行向税务部门按月申报缴纳。个人缴费由用人单位按月代扣代缴，税务部门统一征收。按照国家、省相关规定，将职工基本医保单位费率由7.3%调整为7.15%，调整的0.15%用作长护险单位缴费费率。

2.退休人员。缴费费率为0.15%，缴费基数为上年度本人基本养老金(当年退休的以首次领取的基本养老金月标准为缴费基数)，原用人单位不缴费，经个人同意，长护险个人缴费由医保部门按月从其职工基本医保个人账户中代扣代缴,积极推动实现养老金代扣；无法代扣代缴的，个人自行向税务部门申报缴纳。退休时未达到职工基本医保规定缴费年限,暂停职工基本医保关系并转为参加城乡居民基本医保的,按未就业城乡居民长护险政策参保缴费。

3.灵活就业人员。缴费费率为0.3%，缴费基数为上年度全省社会平均工资的60%。灵活就业人员选择按此政策参保缴费的，其职工基本医保缴费费率由9.3%调整为9.15%。长护险保费由个人在缴纳职工医保费时同步缴纳。

（二）未就业城乡居民

缴费基数为上年度全省城乡居民人均可支配收入，按照

0.2%费率起步，筹资由个人缴费和政府补助按照1:1同比例分担。今后按照省医保局、财政厅统一规定调整。扣除中央和省级财政补助后的地方财政承担部分，按照现行基本医保财政管理体制，由市与县（市、区）分级承担。

18周岁以下（截至缴费所属期上年度12月31日止）未就业人员跟随父母或其他法定抚养人等参保，不单独筹资。孤儿、事实无人抚养儿童等人员中无法随同参保的特殊人员，由民政等部门认定后可视同参保。

第七条 政府对特困人员、低保对象、符合条件的防止返贫致贫对象等困难人群个人缴费部分予以分类资助，资助方式参照资助参加基本医保政策执行。

第八条 职工基本医保个人账户可以用于本人及近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）参加长护险的个人缴费。

第九条 长护险退费情形及流程参照基本医保有关规定执行。

第三章 待遇保障

第十条 按规定在我市参保缴费且失能状态长期持续（一般为6个月以上），经申请失能等级评估认定为重度失能的参保人员，自评估结论作出次月起按规定享受长护险待遇。根据国家和省级统一部署，逐步扩大保障对象范围。

第十一条 参保人员可根据实际情况自主选择通过居家、社区、机构护理方式，享受长护险护理服务待遇。按规定流程变更护理服务方式的，从次月起按变更后的服务方式享受待遇。

（一）居家护理是指长护服务机构在参保人员所居住的家庭住所内为参保人员提供长期护理服务。

（二）社区护理是指长护服务机构以社区为依托，为参保人员提供就近就便、非全日的长期护理服务。

（三）机构护理是指长护服务机构在所开设的机构内为参保人员提供全日的长期护理服务。

第十二条 待遇享受不设起付线，实行限额支付。按就业人员政策参保缴费的，基金支付限额为重度失能一级1300元/月·人、重度失能二级1365元/月·人、重度失能三级1495元/月·人；按未就业城乡居民政策参保缴费的，基金支付限额为重度失能一级845元/月·人、重度失能二级975元/月·人、重度失能三级1040元/月·人。根据国家、省相关要求，动态调整待遇标准。

第十三条 鼓励参保人员选择居家和社区护理服务。参保人选择居家护理服务的，按服务时长付费，支付标准为65元/时。按就业人员参保政策参保缴费的，重度失能一级、二级、三级每月长护险基金累计支付的服务时长分别不超过20、21、23小时；按未就业城乡居民参保政策参保缴费的，重度失能一级、二级、三级每月长护险基金累计支付的服务时长分别不超过13、15、

16 小时。社区护理服务支付限额参照居家护理标准执行。

第十四条 参保人员选择机构护理服务的，按床日付费。按就业人员参保政策参保的，重度失能一级、二级、三级分别为 41 元/床日、43 元/床日、48 元/床日；按未就业城乡居民参保政策参保的，重度失能一级、二级、三级分别为 27 元/床日、31 元/床日、33 元/床日。

第十五条 执行国家层面统一的长护险服务项目目录，目前主要包括生活照护类和医疗护理类两部分。今后根据国家、省统一部署，逐步将长期护理相关智能化服务和支持性辅助器具等纳入支付范围。参保人员（或监护人）和定点长护服务机构根据长护服务需求协商确定具体护理服务计划。

第十六条 参保人员凭医保电子凭证或社保卡申请长护险待遇，应由长护险基金支付的费用由医疗保障经办机构与定点长护服务机构按月结算。

第十七条 待遇享受条件。

（一）除新生儿等特殊群体外，未在我市长护险启动时参保的人员，须连续参保缴费 2 年（含）以上且全额补缴后，方可申请享受待遇。因个人原因中断参保 3 个月以上的，设置固定待遇享受等待期 6 个月，每多断保 1 年，在固定待遇享受等待期基础上增加变动等待期 1 个月；参保人员可通过缴费修复变动等待期，每多缴纳 1 年可减少 1 个月变动等待期。补缴标准按照补缴当年的筹资政策执行，补缴后中断参保期间的待遇不予追溯。

（二）就业人员未按规定缴费的，从欠缴次月起暂停长护险待遇；未就业城乡居民未缴纳下一年度保费的，从下一年度1月1日起暂停长护险待遇。参保人员在长护险待遇享受期间变更参保身份并在3个月（含）内接续参保的，自缴费次月起按新身份享受待遇。

（三）待遇保障对象出现下列情形之一的，应当及时办理长护险待遇终止手续，同步停止相关护理服务。

1.待遇保障对象死亡的；

2.自理能力好转，经再次评估未达到待遇享受条件的；

3.长护险评估结论有效期届满，经复评不符合待遇享受条件的；

4.国家、省、市规定的其他情形。

第十八条 按照国家和省统一部署，做好长护险与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。鼓励商业保险机构开发与政策性长护险制度衔接补充的商业长护险产品。

第四章 失能评估

第十九条 失能等级评估按照国家医保局统一制定的评估标准、管理办法、操作指南的规定执行。

第二十条 各级医疗保障经办机构对失能评估机构实行定点管理。综合考虑失能人员总体规模、评估行业发展实际、管理

服务能力等，合理确定定点评估机构数量。

第二十一条 根据评估经营成本、评估市场规模、评估机构定点分布等因素确定失能等级评估服务费，失能等级评估管理相关政策由市级医疗保障部门会同相关部门另行制定。

第二十二条 建立失能等级评估费用科学合理分担机制。参保人首次申请且通过评估的，评估服务费由长护险基金全额支付；未通过评估的，由个人全额承担；按要求开展定期复评的，由基金全额支付。对评估结果有异议申请复评的，复评结论与初评结论一致或不符合待遇享受条件的，费用由个人承担；经复评结论与初评结论不一致且符合待遇享受条件的，由基金全额支付。

第二十三条 评估有效期届满前三个月内应组织对需继续享受长护险待遇的参保人员进行重新评估。经评估符合待遇享受条件的，上一评估有效期届满后重新计算。若失能等级发生变化或不符合长护险基金支付条件的，应从评估结论作出次月起调整或取消其长护险待遇。

第五章 服务供给

第二十四条 市级医疗保障部门根据参保人员长期护理服务需求、长护险基金收支、长期护理服务资源等情况，统筹规划区域内长护服务机构的资源配置，并实行定点管理。

第二十五条 本市范围内具备护理能力和资质的医疗机构、

养老服务机构、护理机构或者业务范围包括养老服务、照护服务、护理服务的其他服务机构，可自愿向辖区医疗保障经办机构申请成为定点长护服务机构。

第二十六条 在确保基金安全运行和管理的前提下，通过公开招标等竞争性方式有序规范引入的社会力量（以下简称“第三方机构”），可参与经办管理服务，相关费用按协议约定从基金中支付。

第二十七条 建立健全对失能等级评估机构、长护服务机构及第三方机构的考核评价机制。构建长护险经办、失能等级评估和护理服务文书体系，统一规范全流程文书管理。推进长护险“一人一档”建设。

第六章 基金管理和监督

第二十八条 长护险基金纳入社会保障基金财政专户，单独建账、独立核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用。按照社会保险基金预算编制要求，坚持以收定支、收支平衡，科学编制长护险基金收支预算，严格预算执行，加强绩效管理，健全基金预算管理制度。严格执行基金财务制度，加强基金财务管理，规范基金收支。做好基金会计核算和统计分析。建立基金运行监控和风险防范机制，在长护险基金出现支付困难时，应当按规定及时调整筹资或待遇政策。

第二十九条 长护险基金主要用于支付待遇保障、失能等级

评估、第三方机构经办服务等费用，原则上不直接向失能人员发放现金。对机构床位费、膳食费等非护理服务费用以及应由医疗保险支付的医疗费用，基金不予支付。领取工伤保险生活护理费的参保人员，不重复享受长护险有关服务待遇。

第三十条 各级医疗保障部门依据相关法律、法规对长护险基金使用进行监督。建立健全基金监管体系，创新监管手段和方式，加强对定点机构以及护理人员、评估人员的监管。建立健全社会监督机制，完善长期护理服务行业自律机制和欺诈骗保人员、机构惩戒机制。建立健全跨部门监管机制，加强“行行衔接”“行纪衔接”“行刑衔接”和追责问责，推进重要线索、重大案件联查联办。

第七章 附 则

第三十一条 各县（市、区）人民政府加强辖区内长护险各项工作的推进、监督与管理，及时足额上划应由县（市、区）承担的长护险财政补助资金。市级医疗保障部门负责长护险的组织实施，严格按照有关规定，加强对参保服务、失能评估、待遇支付、协议管理等各环节的监督管理，做好对长护险基金运行情况分析，确保长护险基金安全可持续；市委宣传部、市委网信办、市发展改革委、市公安局、市经济和信息化局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市司法局、市卫生健康委、市市场监管局、市统计局、市残联、市税务局、市政务服务和公共资

源交易管理办公室、内江金融监管分局等部门（单位）按照各自职责协同开展长护险相关工作。

第三十二条 本实施细则自2026年10月23日起施行，有效期5年。国家、省有新规定的，从其新规定。